

Rapport de Situation de la 17e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°148 /MVE-BDBV/09/10/2026

Date du rapport : 09 octobre 2026 Date de publication : 10 octobre 2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Une amélioration du taux de positivité est observée, passant de 20,4 % le 02 octobre à 16,0 %, soit une baisse de 4,4 points, malgré une augmentation de 33,4 % des échantillons analysés (431 contre 323).
- Au cours des dernières 24 heures, 69 nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans cinq provinces : Ituri (47), Nord-Kivu (17), Tshopo (2), Bas-Uélé (2) et Haut-Uélé (1), contre 66 cas le 02 octobre, soit une légère augmentation de 3 cas (+4,5 %).
- Quarante décès ont été enregistrés, contre 38 le 02 octobre, dont 30 décès communautaires contre 22 et 10 décès dans les CTE contre 16.
- La réduction des décès dans les CTE (−37,5 %) et la baisse du taux de positivité constituent des évolutions encourageantes. Toutefois, l'augmentation des décès communautaires appelle au renforcement de la détection précoce, du référencement rapide et de la prise en charge des patients.

CUMUL DES CAS	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS	LETALITE	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE	CUMUL DES GUÉRIS	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)
8914	4 315	48,4 %	946	2 338	83,1%

Provinces touchées et zones de santé touchées

7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi

65 Zones de santé touchées sur 167 (38,9%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Des progrès sont observés dans la prise en charge et le diagnostic biologique, avec une réduction des décès dans les CTE, passés de 16 le 02 octobre à 10 le 09 octobre (−37,5 %), ainsi qu'une baisse du taux de positivité de 20,4 % à 16,0 %, malgré une augmentation de 33,4 % des échantillons analysés.

Au cours des dernières 24 heures, 69 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans cinq provinces : Ituri (47), Nord-Kivu (17), Tshopo (2), Bas-Uélé (2) et Haut-Uélé (1), contre 66 cas le 02 octobre, soit une légère augmentation de 4,5 %.

Quarante décès confirmés ont été enregistrés, contre 38 le 02 octobre, dont 30 décès communautaires contre 22 et 10 décès dans les CTE contre 16. Par ailleurs, 18 patients ont été déclarés guéris en Ituri, contre 31 guérisons enregistrées au niveau national le 02 octobre.

Au 09 octobre 2026, la RDC cumule 8 914 cas confirmés et 4 315 décès, soit une létalité de 48,4 %. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 74,1 % des cas cumulés et 68,1 % des nouveaux cas.

Depuis le début de l'épidémie, 65 zones de santé sur 167 (38,9 %), réparties dans sept provinces, ont été historiquement touchées et 12 ZS ont atteint au moins 42 jours sans nouveau cas confirmé. Trois ZS se situent entre 22 et 42 jours sans nouveau cas confirmé.

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CAS ET DÉCÈS CONFIRMÉS PAR PROVINCE ET SITUATION DES ZONES DE SANTÉ, AU 09 OCTOBRE 2026

Province	Nouveaux cas confirmés (24 h)	Cas confirmés cumulés	Décès confirmés cumulés	Létalité	ZS historiquement touchées	ZS actuellement affectées* (08/10)
Ituri	47	6 609	3 065	46,4 %	28/36 (77,8 %)	25/36
Nord-Kivu	17	1 858	1 065	57,3 %	17/34 (50,0 %)	15/34
Haut-Uélé	1	372	157	42,2 %	7/13 (53,8 %)	7/13
Tshopo	2	57	22	38,6 %	7/23 (30,4 %)	5/23
Sud-Kivu	0	3	1	33,3 %	1/34 (2,9 %)	0/34
Bas-Uélé	2	13	4	30,8 %	4/11 (36,4 %)	4/11
Sud-Ubangi	0	2	1	50,0 %	1/16 (6,3 %)	1/16
Total	**69**	**8 914**	**4 315**	**48,4 %**	**65/167 (38,9 %)**	**57/167**

Commentaires :

Au 09 octobre, 69 nouveaux cas sont notifiés contre 58 le 08 octobre et 66 le 02 octobre. La létalité nationale est de 48,4 % (4 315 décès/8 914 cas). L'Ituri concentre 47 des 69 nouveaux cas (68,1 %).

La baisse des décès en CTE par rapport au 02 octobre (10 contre 16) est encourageante, mais les décès communautaires augmentent (30 contre 22). Le taux de positivité recule de 20,4 % à 16,0 % entre ces deux dates, avec 431 échantillons analysés contre 323.

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 09 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	**6609**	**3065**	**46,4%**	**47**	**25**	**4**	**29**
Adja	12	1	8,3%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	213	47	22,1%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1804	601	33,3%	6	1	1	2
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	84	31	36,9%				0
Gethy	9	5	55,6%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	38	12	31,6%				0
Komanda	176	107	60,8%				0
Lita	297	150	50,5%	2	1	0	1
Logo	14	7	50,0%				0
Lolwa	35	9	25,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	41	17	41,5%				0
Mandima	235	123	52,3%	18	14	1	15

Mangala	369	160	43,4%	3	3		3
Mongbwalu	710	339	47,7%	0	0	1	1
Nia-Nia	320	181	56,6%	3	3		3
Nizi	806	290	36,0%	4	1		1
Nyankunde	133	39	29,3%				0
Rimba	18	5	27,8%	4	0	0	0
Rwampara	1128	391	34,7%	7	2	1	3
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	NA	493	NA!				0
Nord-Kivu	**1858**	**1065**	**57,3%**	**17**	**5**	**6**	**11**
Beni	437	293	67,0%	7	5	5	10
Biena	23	7	30,4%				0
Butembo	295	185	62,7%	2	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	67	24	35,8%	1	0		0
Katwa	620	379	61,1%	1	0		0
Kayna	3	2	66,7%				0
Kyondo	37	20	54,1%				0
Lubero	23	11	47,8%				0
Mabalako	56	21	37,5%	1	0		0
Alimbongo	5	3	60,0%				0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	36	11	30,6%				0
Musienene	142	69	48,6%	1	0		0
Mutwanga	23	4	17,4%	3	0		0
Oicha	38	18	47,4%	1	0		0
Vuhovi	39	13	33,3%			1	1
Haut-Uélé	**372**	**157**	**42,2%**	**1**	**0**	**0**	**0**
Boma Mangbetu	44	19	43,2%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	98	47	48,0%	1	0	0	0
Rungu	4	2	50,0%				0
Wamba	120	43	35,8%				0
Tshopo	**57**	**22**	**38,6%**	2	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	6	1	16,7%	1	0	0	0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	30	12	40,0%	1	0	0	0
Mangobo	10	7	70,0%				0
Tshopo	2	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0

Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	**13**	**4**	**30,8%**	2	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Dakwa	1	0	0,0%				0
Ganga	5	2	40,0%	2	0	0	0
Sud Ubangi	**2**	**1**	**50,0%**	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	**8914**	**4315**	**48,4%**	**69**	**30**	**10**	**40**

Une réduction des décès intra-CTE est observée, passant de 16 le 02 octobre à 10 le 09 octobre (−37,5 %). Toutefois, 69 nouveaux cas confirmés ont été notifiés, contre 66 le 02 octobre, soit une légère augmentation de 4,5 %.

L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 47 nouveaux cas (68,1 %), dont 18 à Mandima, qui enregistre également 15 décès, dont 14 communautaires. Au Nord-Kivu, Beni constitue le principal foyer de préoccupation avec 7 nouveaux cas et 10 décès, dont 5 communautaires et 5 intra-CTE.

Des signaux encourageants sont observés au Haut-Uélé, à la Tshopo et au Bas-Uélé, qui totalisent seulement 5 nouveaux cas sans décès rapporté au cours des dernières 24 heures. Aucun nouveau cas n'est signalé au Sud-Kivu et au Sud-Ubangi.

Au niveau national, 8 914 cas confirmés et 4 315 décès sont cumulés, soit une létalité de 48,4 %.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 09 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	104	6	110	15	5	0	0	20	12
Bas Uélé	139	2	141	16	2	123	0	18	0
Ituri	1 194	84	1278	111	84	1 083	0	195	79
Nord-Kivu	1 411	56	1467	173	56	1 238	0	229	128
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	153	0	153	11	0	142	0	11	0
Total Général	**3 001**	**148**	**3 149**	**326**	**147**	**2 586**	**0**	**473**	**219**

Une performance satisfaisante de la surveillance est observée, avec 3 149 alertes notifiées dans les cinq provinces déclarantes, dont 473 validées comme cas suspects (15,0 %). La totalité des 473 suspects a été investiguée (100 %), traduisant une bonne réactivité des équipes de surveillance.

L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent 87,2 % des alertes (2 745/3 149) et 89,6 % des suspects validés (424/473), confirmant la nécessité d'y maintenir une surveillance renforcée. Par ailleurs, 219 suspects ont été transférés vers les CT/CTE, soit 46,3 % des suspects investigués

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

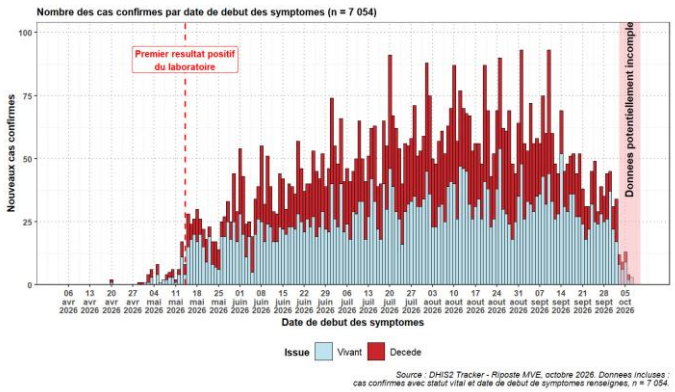
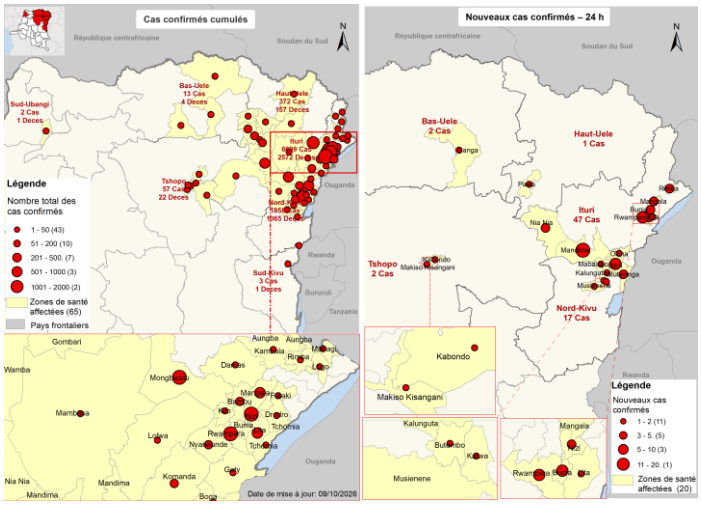


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Poursuite de l'appui et du suivi des activités de riposte dans les provinces affectées, à travers les différents piliers techniques, en vue de renforcer la coordination, la complémentarité des interventions et la résolution des difficultés opérationnelles ;
- Tenue des réunions de coordination nationale et des échanges inter piliers pour évaluer les performances de la riposte, identifier les gaps opérationnels et assurer le suivi des recommandations ;
- Organisation du **briefing des membres des comités de gestion de 24 universités de Bunia**, axé sur la situation épidémiologique de la MVE, les modes de transmission, les mesures de prévention et le rôle des institutions universitaires dans la sensibilisation, la mobilisation communautaire et la lutte contre l'épidémie ;
- Poursuite de l'accompagnement technique des coordinations provinciales, notamment dans le renforcement de la surveillance, de la prise en charge, de la prévention et du contrôle des infections ainsi que de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire ;
- Poursuite de la mission d'appui des experts nationaux dans la zone de santé de Mandima, en Ituri, pour renforcer les interventions de terrain et contribuer à l'interruption des chaînes de transmission ;
- Renforcement des échanges avec les partenaires techniques et financiers pour assurer la mobilisation des ressources, le suivi des engagements et la continuité des interventions prioritaires.

1.2. Défi majeur

La persistance des foyers actifs de transmission, particulièrement à Mandima (Ituri) et à Beni (Nord-Kivu), associée aux décès communautaires et aux contraintes sécuritaires constitue le principal défi de la coordination

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Pour le **09 octobre 2026**, **3149** alertes ont été rapportées dans cinq provinces. 3059 ont été vérifiées (**97,1 %),** dont **473 (15,5 %)** ont été validées comme cas suspects et **2586 (84,3 %)** invalidées. Les **473** cas suspects ont tous été investigués (**100,0 %).** Parmi eux, **219 (46,3 %)** ont été transférés vers les CT/CTE

Parmi 31 476 contacts en cours de suivi, 26 170 ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de 83,1 %, en baisse par rapport à la veille (83,5 %) et inférieure au seuil requis de 95,0 %. Par province, cette proportion était de 91,0 % (600/659) à la Tshopo, 90,5 % (1 964/2 170) au Haut-Uélé, 84,8 % (189/223) au Bas-Uélé, 84,1 % (13 659/16 251) au Nord-Kivu et 80,2 % (9 758/12 173) en Ituri ; le Sud-Ubangi n'a pas transmis ses données (ND). Aucune province n'atteint le seuil de 95 %.

2.1.2. Défi majeur

La faible performance du suivi des contacts demeure le principal défi, avec une couverture nationale de 83,1 %, en baisse par rapport à la veille (83,5 %) et inférieure à la cible de 95 %, particulièrement en Ituri (80,2 %) et au Nord-Kivu (84,1 %). Cette situation, associée aux contraintes sécuritaires dans certaines zones risque de compromettre la détection précoce et l'interruption des chaînes de transmission.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Quatre (4) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC le 09 octobre : soit trois (3) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu, et une (1) au Haut-Uélé. En Ituri, l'alerte vivante validée au PoC Mabakese (ZS de Mambasa) n'a pas été référée au CTE de Mambasa faute de places disponibles, et deux corps sans vie interceptés au PoC Route Watsa (ZS d'Aru) ont été swabés par l'équipe EDS (résultats en attente). Au Nord-Kivu, l'alerte vivante notifiée au PoC Kahongo a été invalidée après investigation approfondie.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 09 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	95,1% (58/61)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	96,0% (96/100)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	138 913	87 583	21 210	247 706
% des voyageurs screenés	97,9%	97,8%	98,5%	97,9%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,5%	97,8%	98,3%	97,7%
% des voyageurs sensibilisés	98,7%	97,8%	100,0%	98,5%
Nombre d'alertes notifiées	3	1	0	4
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	0	0	1
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	2	0	0	2
% des cas suspects transférés au CTE/CT	0,0%	NA	NA	0,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	NA	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.2.2. Défis

L'insuffisance des capacités d'accueil dans les CTE, particulièrement à Mambasa (Ituri), constitue un défi majeur, compromettant le référencement rapide des cas suspects détectés aux PoE/PoC et augmentant le risque de propagation de la MVE. Cette situation est aggravée par les contraintes logistiques et sécuritaires, ainsi que par les difficultés de suivi des alertes et des mouvements transfrontaliers.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 47 nouveaux résultats positifs** (22 vivants et 25 décès) sur 218 échantillons reçus et analysés **(positivité : 21,6 %) ;**
- **Nord-Kivu : 17 nouveaux résultats positifs** (12 vivants et 5 décès) sur 156 échantillons reçus et analysés **(positivité : 10,9%) ;**
- **Haut-Uélé : 1 nouveau résultat positif (**1 vivant) **sur 13 échantillons reçus et analysés (positivité : 7,7%) ;**
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs (2 sangs) sur 11 échantillons reçus et analysés (positivité : 18,2%) ;**
- **Bas Uélé : 2 nouveaux résultat positif** (2 sangs) sur 33 échantillons reçus et analysés **(Positivité : 6,1%).**

2.3.2. Défi majeur

La persistance d'une forte positivité des échantillons en Ituri (21,6 %), particulièrement parmi les décès communautaires (25 cas positifs), constitue un défi majeur, traduisant une circulation préoccupante du virus et des insuffisances dans la détection précoce des cas. À cela s'ajoutent les contraintes liées à l'acheminement rapide des échantillons depuis les zones difficiles d'accès et à la disponibilité continue des intrants de laboratoire.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri :** 22 rings ont été ouverts sur 34 (64,7 %), 46 ménages décontaminés sur 55 (83,6 %) et 4 FOSA décontaminées sur 4 (100 %) ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Sur 91 alertes EDS (dont 10 reports de la veille), 57 EDS ont été réalisés (62,6 %) et 63 corps swabés, avec 26 échecs (28,6 %) liés aux résistances à Komanda, Nyakunde, Mongbwalu, Nia-Nia, Fataki et Mandima ;
- **Nord-Kivu :** 26 rings ont été ouverts sur 46 (56,5 %), avec un gap important à Katwa et à Beni, 29 ESS décontaminées sur 33 (87,9 %) et 18 ménages sur 54 (33,3 %), aucun des ménages décontaminés n'ayant été doté en kits ; 16 évaluations PCI (score card) ont été réalisées dans 16 ESS avec un score moyen de 33,2 % et 3 PPL infectés sur 30 cas confirmés (10,0 %) ont été notifiés (2 à Katwa et 1 à Butembo). Sur 77 décès attendus (36 alertes et 51 reports), 50 EDS ont été réalisés (64,9 %) et 36 corps swabés sans échec, avec 37 reports au jour suivant ; des dispositifs de lavage des mains ont été installés à l'EP BEU et 3 salles de classe ont été décontaminées dans 3 écoles de la ZS de Beni ;
- **Haut-Uélé :** 3 ESS sur 3 prévues ont été décontaminées dans la ZS d'Isiro (100 %), 15 ESS ont été supervisées et 9 évaluées au score card (7 à Isiro et 2 à Pawa), aucune n'atteignant 80 %, 66 prestataires sur 77 (85,7 %) ont été briefés et 2 kits PCI de catégorie 3 ont été dotés aux CS Maman Kahenga et Tshakatshaka (ZS de Wamba) ; aucun ring n'a été ouvert autour des 3 cas en provenance de Bolebole. Sur 5 alertes EDS, 3 EDS ont été réalisés (60,0 %) et 5 corps swabés, avec 2 refus d'EDS dans l'AS de N'Sele (ZS d'Isiro).

2.4.2. Défis

La persistance des insuffisances dans la mise en œuvre des mesures de PCI et des enterrements dignes et sécurisés (EDS) constitue un défi majeur, particulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, avec une faible couverture des rings (64,7 % et 56,5 %), des taux de réalisation des EDS encore insuffisants (62,6 % et 64,9 %) et des résistances communautaires persistantes.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri,** 81 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 86 sorties, dont 18 guérisons. 316 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits de 30,6 % : (316/1 015), dont 30 malades critiques ; 325 patients sur 330 (98,5 %) ont reçu un repas chaud et tous les enfants sous LNPE/SLM ont été pris en charge (11/11 au CTE, 6/6 à la crèche et 50/50 dans la communauté). Le cumul des guéris de la province atteint 1 868 ;

- **Au Nord-Kivu,** 121 nouvelles admissions (17 confirmés et 104 suspects) ont été enregistrées contre 121 sorties et aucune guérison). Au total, 523 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation des lits des CTE/CT de 87,2 % : (326/374), dont 19 malades critiques au CTE de Beni ; 148 patients (31,2 %) sont pris en charge dans des ESS qui ne sont pas des CTE/CT, et 91 patients, 12 accompagnants et 171 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **Au Haut-Uélé,** 71 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 4 sorties. Au total, 71 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 53,6 % ; 2 malades critiques ; 50 patients, 65 accompagnants et 70 PPL ont reçu des repas chauds ;
- **À la Tshopo,** 1 nouvelle admission (1 confirmé) a été enregistrée. Aucune sortie n'a été rapportée. Au total, 15 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation global des lits de 41,7 % (15/36) ; depuis le début, 430 personnes ont reçu le traitement expérimental, dont 37 cas confirmés, et 429 ont bénéficié de la prophylaxie post-exposition ;
- **Au Bas-Uélé,** 16 nouveaux cas suspects ont été admis dans les centres de transit (Bondo 7, Viadana 4, Ganga 3, Buta 1 et Dakwa 1), sans aucune sortie ; au total, 26 patients sont rapportés en isolement, mais les 2 nouveaux cas confirmés de la ZS de Ganga ne sont pas encore isolés ni pris en charge et leur transfert sécurisé est planifié en urgence.

2.5.2. Défis

La saturation des capacités de prise en charge au Nord-Kivu, particulièrement à Beni, et l'insuffisance du référencement rapide des cas suspects et confirmés constituent les principaux défis. Le taux d'occupation des lits atteint 87,2 % dans les CTE/CT, tandis que 148 patients (31,2 %) sont pris en charge dans des structures non dédiées, augmentant les risques de transmission nosocomiale. Au Bas-Uélé, deux cas confirmés à Ganga demeurent non isolés et non pris en charge. À ces difficultés s'ajoutent les besoins persistants en personnel qualifié, en intrants médicaux, en alimentation et en moyens de transport sécurisé.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**le, **le** préenregistrement des PPL et TPL (leaders religieux, RECO, tradipraticiens, motards et chasseurs) s'est poursuivi, le cumul provincial restant de 1 500 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (11,4 %), principalement à Buta (620 ; 21,6 %), à Ganga (273 ; 20,5 %) et à Viadana (243 ; 9,8 %) ; le stock provincial de vaccin Ervebo est épuisé (0 dose) ;
- **Au Haut-Uélé**, 100 PPL ont été vaccinés contre la MVE au premier jour de la campagne lancée le 08 octobre 2026 par le Gouverneur de province ;
- **En Ituri,** la collecte des données de l'étude sur l'impact de l'épidémie de MVE sur l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive s'est poursuivie dans les ZS de Mongbwalu, Bunia, Rwampara, Tchomia et Nyarambe, de même que les enquêtes qualitatives et opérationnelles et les essais cliniques Partners, Oracle et EBO-PEP.

2.6.2. Défis

La rupture totale du stock de vaccin Ervebo au Bas-Uélé constitue le principal défi, compromettant la poursuite de la vaccination des personnes à risque, alors que la couverture provinciale demeure faible (11,4 % de la cible). À cela s'ajoute la nécessité d'assurer la disponibilité continue des vaccins et des intrants pour consolider le démarrage de la campagne au Haut-Uélé et intensifier la protection des personnels de première ligne et des autres groupes prioritaires.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo,** l'évaluation du CS RTNC a révélé l'absence de zone de triage effective, des prestataires travaillant sans gants, l'absence d'incinérateur fonctionnel, aucun prestataire formé sur la MVE et 5 agents vaccinés sur 28 (17,9 %) ; le plan de redressement du CS Bondeko a été élaboré, et le suivi des PPL au CTM et au CTE ainsi que celui des guéris présentant des comorbidités à l'HGR de Makiso-Kisangani se sont poursuivis ;

- **Au Bas-Uélé,** l'évaluation de l'HGR de Viadana montre une baisse de l'utilisation des services entre mai (7 009) et septembre 2026 (4 874), un taux d'occupation des lits de 20 % en septembre pour 70 % attendus, l'absence de zone de triage et de protection des PPL, et 16 PPL vaccinés sur 16 **;**
- **Au Nord-Kivu, les** membres de l'ECZ et les prestataires des ESS de la ZS de Beni ont été briefés sur la continuité des services de santé essentiels et le pilier a participé au lancement, par IMC, du projet de maintien des services de santé essentiels dans le contexte de la MVE ;
- **Au Bas-Uélé,** aucune donnée n'a été transmise par le pilier continuité des soins au cours des dernières 24 heures**.**

2.7.2. Défi majeur

La faible capacité des structures sanitaires à assurer la continuité des services de santé essentiels dans des conditions sécurisées constitue le principal défi, particulièrement à la Tshopo et au Bas-Uélé. Cette situation se caractérise par l'insuffisance des dispositifs de triage, des équipements de protection et de la formation des prestataires, ainsi que par la faible couverture vaccinale des personnels de première ligne. La baisse de fréquentation des services de santé, notamment à l'HGR de Viadana, constitue également une préoccupation majeure.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri,** 22 719 visites à domicile ont touché 71 562 personnes ; 614 causeries éducatives ont réuni 3 307 personnes, 122 sensibilisations de masse 5 074 personnes, 18 débats communautaires 639 personnes et 9 plaidoyers 21 autorités et leaders ; 21 spots ont été diffusés sur 36 stations de radio et 12 émissions organisées. Au total, 357 alertes communautaires, dont 127 décès, ont été notifiées ; 68 feedbacks sur 83 (81,9 %) et 5 incidents sur 7 (71,4 %) ont été résolus dans les 48 heures, 55 membres des comités de gestion, du corps académique et des étudiants de Bunia ont été briefés en prélude à la rentrée académique et 229 contacts ont été pré-listés autour de 21 cas confirmés. La complétude des rapports CREC n'est que de 36 % (10/28 ZS) ;
- **Au Bas-Uélé,** 145 visites à domicile ont touché 503 personnes à Likati, Monga, Ganga et Viadana, 2 causeries éducatives 28 personnes et 2 séances de sensibilisation de masse 539 personnes ; 77 personnes ont été sensibilisées autour des cas positifs de Dakwa et de Ganga, 18 contacts ont été listés à Dakwa et un plaidoyer a été mené auprès des chefs de chefferie de Kassa et de Deni (ZS de Monga) ;
- **À la Tshopo,** 279 visites à domicile ont touché 1 563 personnes, 3 causeries éducatives 123 personnes et 8 séances de sensibilisation de masse 7 875 personnes, principalement en milieu scolaire ; 105 alertes communautaires, dont 1 décès, ont été notifiées et toutes traitées, les 3 feedbacks reçus ont été résolus (100 %) et 125 contacts ont été suivis ;
- **Au Haut-Uélé,** 15 causeries éducatives, 3 séances de sensibilisation de masse et 122 visites à domicile ont touché 2 712 personnes à Isiro, Wamba et Watsa, et 42 RECO et membres CREC ont été formés ; 54 alertes communautaires, dont 6 décès, ont été notifiées dans 5 ZS et aucun des 13 feedbacks reçus n'a encore été résolu. La vaccination des PPL contre la MVE a été lancée par le Gouverneur de province en présence de l'Incident Manager.

2.8.2. Défi majeur

La persistance des résistances communautaires, associée à la faible complétude des rapports CREC en Ituri (36 %) et aux insuffisances dans la gestion des feedbacks, constitue le principal défi.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu,** 10 sur 20 derniers cas confirmés (50,0 %), 78 confirmés en cours de suivi sur 129 (60,5 %), 26 nouveaux suspects sur 81 (32,1 %) et 89 suspects en cours de suivi sur 120 (74,2 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 233 accompagnants et 88 PPL, suivi 19 guéris sur 23 (82,6 %) en communauté et 14 enfants sur 14 en crèche, accompagné 21 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 25 (84,0 %),

réinséré 15 guéris sur 15 (100 %), réalisé 1 réunification familiale et annoncé 45 résultats, dont 10 positifs ; 113 enfants sont suivis ;

- **À la Tshopo**, 3 sur 4 derniers cas confirmés (75,0 %), 5 confirmés en cours de suivi sur 5 (100 %), 1 nouveau suspect sur 1 et 7 suspects en cours de suivi sur 7 (100 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 4 ménages ont été accompagnés, 1 PPL soutenu, 1 guéri suivi en communauté, 660 personnes ont bénéficié de la psychoéducation et 4 résultats, tous positifs, ont été annoncés ; 3 résistances sur 4 ont été brisées et 5 ZS sur 7 ayant notifié sont couvertes ;
- **Au Haut-Uélé,** 3 nouveaux cas confirmés, 23 confirmés en cours de suivi, 6 nouveaux suspects et 28 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans les CTE d'Isiro, Pawa, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 31 accompagnants, 63 PPL, 10 enfants séparés en communauté et 9 membres de ménages, appuyé 1 EDS et annoncé 19 résultats, dont 3 positifs.

2.9.2. Défis

La couverture encore insuffisante des interventions de santé mentale et de soutien psychosocial, particulièrement au Nord-Kivu, constitue le principal défi.

2.10. Sécurité

2.10.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, l'ordre public a été rétabli au bureau du quartier Bundji à la suite de l'agression de l'équipe EDS par la population, sans dégât enregistré ; les équipes PCI ont été escortées pour la décontamination de 4 sites de l'AS de Kanzulinzuli et de l'EP La Modestine ainsi que d'un ménage de l'AS de Kasanga, l'équipe EDS pour l'enterrement d'un cas confirmé à Lubero et le partenaire FHI 360 pour l'état des lieux de l'AS de Kambuli (Katwa). Au Bas-Uélé, une évaluation sécuritaire de Dakwa et de l'axe y menant depuis Buta a été réalisée et une escorte mixte a été constituée pour accompagner l'équipe de riposte.

2.10.2. Défi majeur

La persistance des incidents sécuritaires et des résistances communautaires à l'encontre des équipes de riposte constitue le principal défi, particulièrement au Nord-Kivu, où l'agression d'une équipe EDS à Bundji illustre les risques auxquels sont exposés les intervenants. Au Bas-Uélé, la nécessité d'organiser une escorte mixte vers Dakwa témoigne des contraintes sécuritaires pouvant entraver l'accès aux zones affectées et la continuité des interventions.

2.11. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.11.1. Principales actions

- **En Ituri,**l 33 prestataires des CTE de Bambu, de Nizi et de Medair (9 femmes et 24 hommes) ont été briefés sur la PSEAH et 55 personnes (24 femmes, 12 hommes, 16 filles, dont 1 PVH, et 3 garçons) ont été sensibilisées sur la PSEAH et les canaux de signalement (151 et 495555) dans les AS Mudzimaria, Kindia et CNCA (ZS de Bunia) ; la formation des enseignants, comités de parents, leaders communautaires et associations féminines a été clôturée à Tchomia (20 participants, dont 8 femmes et 12 hommes) et à Komanda (57 participants, dont 33 femmes et 24 hommes), et 1 420 élèves et personnels des écoles Autsai et An-Nur d'Aru (678 filles, 694 garçons, 19 femmes et 29 hommes) ont été sensibilisés. L'affichage des messages et la distribution des dépliants se sont poursuivis à Bunia, Aru, Mongbwalu, Mambasa et Fataki ;
- **Au Nord-Kivu,** 76 personnes (56 hommes, dont 3 PVH, et 20 femmes) ont été briefées sur la PSEAH à Beni au cours de 4 séances (19 prestataires SMSPS, 20 volontaires de la Croix-Rouge et 37 prestataires et leaders locaux), et 140 personnes ont été sensibilisées sur la PSEAH et le signalement via le 151/495555 à Beni (64, AS Paida et Tuungane), Katwa (54, AS Vungi) et Butembo (22, AS Vulind.

2.11.2. Défis

L'insuffisance de la couverture des activités de prévention et de sensibilisation à la PSEAH, ainsi que la nécessité de garantir l'accessibilité, la confidentialité et l'efficacité des mécanismes de signalement, constituent les principaux défis, malgré les efforts de formation des prestataires et de mobilisation communautaire en Ituri et au Nord-Kivu.

2.12. Gestion des bases des données

2.12.1. Principales actions :

- Poursuite de la collecte, de la centralisation, de la consolidation et de l'analyse des données épidémiologiques et opérationnelles provenant des provinces affectées, en collaboration avec les équipes provinciales et les différents piliers de la riposte ;
- Renforcement du contrôle de qualité des données à travers la vérification de leur complétude, de leur cohérence et de leur concordance entre les différentes sources de notification ;
- Poursuite de l'identification et de la correction des doublons, des données manquantes et des incohérences dans les bases de données, particulièrement celles relatives aux cas confirmés, aux décès, aux contacts et aux résultats de laboratoire ;
- Appui à l'actualisation des bases de données et des tableaux de bord de suivi des indicateurs de performance, afin de faciliter l'analyse de la situation épidémiologique et la prise de décision par la coordination nationale ;
- Renforcement de la collaboration entre les équipes de gestion des données, les piliers techniques et les provinces pour améliorer la transmission régulière des informations et l'harmonisation des données utilisées dans les SitRep ;
- Poursuite de l'accompagnement des équipes provinciales dans l'utilisation des outils numériques de collecte et de gestion des données, notamment DHIS2 Tracker.

2.12.2. Défi majeur

La persistance des insuffisances dans la complétude, la qualité, la cohérence et la transmission en temps utile des données constitue le principal défi.

MESSAGES CLES

- La transmission communautaire de la MVE demeure active dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Haut-Uélé, tandis que la Tshopo enregistre des cas sporadiques. Cette situation traduit la persistance de foyers de transmission nécessitant le maintien d'une vigilance accrue et l'intensification des interventions dans les zones de santé affectées.
- La surveillance épidémiologique maintient une bonne performance en matière d'investigation, avec **100 % des cas suspects investigués**. Toutefois, le taux de suivi des contacts connaît une légère baisse, passant de 83,5 % à 83,1 %, et demeure inférieur à la cible opérationnelle de 95 %. Cette situation nécessite un renforcement du suivi des contacts afin de prévenir la persistance de chaînes de transmission non détectées.
- Maintenir une surveillance épidémiologique renforcée, améliorer la couverture et la qualité du suivi des contacts, intensifier les interventions de PCI et de CREC au niveau communautaire, et garantir une prise en charge précoce et de qualité des patients dans des structures dédiées disposant de capacités d'accueil suffisantes, particulièrement dans les foyers de transmission active.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.

TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Contact :

www.sante.gouv.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.